

Heaolu arengukava eesmärkide elluviimisega on sama lugu, mis inimeste individuaalsete eesmärkide elluviimisega: kui ei seata piisavalt mõõdetavaid eesmärke, siis on keeruline hiljem öelda, kas oodatud heaolu saabus või mitte. Kui eesmärkide elluviimiseks on valitud ebasobivad tegevused, siis on keeruline hiljem eesmärgi ja tegevuse vahel seost näha. Kui eesmärk on üllas, aga selle elluviimiseks napib ressursse, siis on eesmärgi saavutamine ebatõenäoline. Kui aga arengukavas seatud eesmärkide nimel päriselt tööd teha, nagu teenuse pakkujad teevad tööd inimestega, siis on meie sotsiaalsektor aastaks 2023 kindlasti tunduvalt kvaliteetsem ja kõrgem ka heaolu tase. **S**

P.S. Mina suutsin kasutada sõnu *kvaliteet* ja *kvaliteetne* neljal leheküljel kokku 42 korda. Kui nii jätkata, on seitsme aasta pärast kõigile selge, mida tähendab kvaliteet.

Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse tegevusi viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015–2020”, alapunkti 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu” raames.

Muudatused rehabilitatsioonisüsteemis:

kuidas tuua vajalikud teenused õigel ajal õige inimeseni?



Gerli Aavik

projektijuht, sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi ja koostööpartnerite ees seisab suur väljakutse: kuidas vastata paremini inimeste ootustele, pakkuda abivajajatele proaktiivset tuge, kuid kulutusi mitte suurendada. Väikeses Eestis on iga inimene asendamatu, seetõttu on toetuste ja teenuste pakumisele õige läheneda nii, et õigeaegne abi tagaks abivajajatele ja nende lähedastele maksimaalse iseseisvuse.

Muudatused rehabilitatsioonisüsteemis

Rehabilitatsiooni korraldus on aastaid

oodanud muudatusi, nüüd on nendega alustatud. 2016. aasta jaanuaris muutus täiskasvanute rehabilitatsiooniteenus vajaduspõhiseks. See tähendab, et lisaks puude või töövõimetuse olemasolule hinnatakse ka seda, kas rehabilitatsiooni raames pakutavad teenused saavad aidata inimesel tegelikult saavutada selle eesmärke või oleks vaja hoopis mingit muud abi, nt kohaliku omavalitsuse tuge või tervishoiuteenuseid. Uus süsteem aitab ressursse õiglasemalt ümber jagada ning toetada neid inimesi, keda pakutavad teenused tõepoolest ka aitavad. Tänu sellele jõuavad

abivajajad kiiremini vajalike teenusteni.

Uue korralduse kohaselt jaguneb rehabilitatsioon eesmärgist lähtudes sotsiaalseks ja tööalaseks, ent paljudele inimestele on rehabilitatsiooni lahutamatuks osaks ka meditsiiniline rehabilitatsioon (eelkõige taastusravi või psühhiaatriline ravi). Ehkki jõustunud muudatused pakuvad lahendusi mitmele probleemile, tuleb süsteemirägestikes alles luua sillad, mis aitaksid igal inimesel just temale vajalikku abi saada võimalikult lihtsalt ning just siis, kui abi on tarvis.

Selleks et keerukas süsteemis selgust luua, alustasime koostööd teenusedisaineriga. Teenusedisainer kaardistab koos eri sihtgruppidesse kuuluvate inimeste, nende esindajate ja ekspertidega klienditeekonnad ning toob välja valupunktid, kus inimestel on oht jääda vajaliku abita.

Abivajajate toetusvõrgustiku tihendamisel on oluline, et protsessis mõtleksid aktiivselt kaasa nii tervishoiu-, hoolekande- kui ka tööhoivesüsteemi töötajad ning lahenduste keskmes oleksid abi vajavad inimesed oma eripärade ja vajadustega.

Intervjuud selgitavad vajadusi

Kompleksne rehabilitatsiooniteenus toetab väga erineva võimekuse ja piirangutega inimesi. Seetõttu peab süsteem olema paindlik ja arvestama inimeste spetsiifilisi vajadusi.

Esimeses etapis keskendume tööealiste inimeste probleemidele. Lahendusi otsides intervjuerime nelja suuremasse sihtgruppi kuuluvaid inimesi. Sihtgrupid on järgmised:

- 1) raske äkilise tervisekahjustusega inimesed, kes näiteks tööõnnetuse, autoavarii või insuldi tagajärjel jõudnud meditsiinisüsteemi ning vajavad taastusravi lõppedes intensiivset tuge ka rehabilitatsioonisüsteemilt
- 2) psüühikahäirega (sh sõltuvushäirega) inimesed, nt skisofreenia diagnoosiga inimesed,

kes vajavad pärast esmast psühhoosi nii intensiivset psühhiaatrilist sekkumist tervishoiusüsteemis kui ka kohest järjepidevat rehabiliteerivat tuge

- 3) kroonilise haigusega inimesed, kes vajavad tuge oma tervisliku olukorraga kohanemisel ja iseseisval toimetulekul, nt artroosi põdev inimene, kes vajab tuge töövõime säilitamisel ja iseseisval toimetulekul
- 4) stabiilse tervisliku seisukorraga inimesed, kes ei vaja regulaarset tuge tervishoiusüsteemilt, kuid kellel on siiski vaja erinevaid teenuseid: nt vaimupuudega inimene, kes vajab lisaks sotsiaalse rehabilitatsioonile tugiisikut kohalikul omavalitsuselt, erihoolekandesüsteemilt igapäevaelu toetavat teenust ja töötukassalt tuge tööalaseks täiendusõppeks.

Intervjueeritavate valikul on oluline, et küsitletavate inimeste vajadused erineksid ning nende teekondade pealt oleks võimalik üles ehitada võimalikult paindlikud ja eri sihtgruppidele sobivaid teekondi liikumisel ühelt teenuselt teisele. Nt insuldist taastuva 55aastase Sirje, äsja esmase psühhoosi läbi elanud 22aastase Martini ning kaasasündinud vaimupuudega 40aastase Priidu individuaalsed vajadused on väga erinevad, ent neid seob see, et nad kõik tahaksid, et pakutav abi oleks õigeaegne, neile arusaadav ja aitaks elada täisväärtuslikku elu.

Arendustöö esimeses etapis kaardistame sihtgruppidesse kuuluvate inimeste ja nende lähedastega vajadused ja senised kogemused. Kaardistusi arutatakse seejärel puuetega inimeste esindusorganisatsioonide esindajatega ja protsessis osaleda soovivate inimestega. Lahenduste leidmisel kutsutakse appi ka tervishoiutöötajad, rehabilitatsioonispetsialistid, sotsiaaltöötajad jt spetsialistid.

Järgmises etapis katsetatakse välja tööatud lahendusi teenuseosutajate juures ning

jälgitakse, mis takistab kehtivas süsteemis inimestele terviklike teenuste pakkumist. Takistusteks võivad olla probleemid infosüsteemidega, segadus eri süsteemides vastutustes ja rollides, koostööpraktikad on ebatõhusad, õigusaktidest või rahastamispõhimõtetest tulenevad piirangud jne. Muudatusettepanekute katsetamise ja tutvustamisega on plaanis alustada 2016. aasta sügisel.

Iga juhtum eeldab terviklikku lahendust

Paralleelselt jätkuvad ka töövõimereformi arendused, mille puhul on samuti esmatähtis, et muudatused lähtuksid inimeste terviklikest vajadustest. Alates jaanuarist hindavad Sotsiaalkindlustusametis ja töötukassas rehabilitatsioonivajadust juhtumikorraldajad. Nad vaatavad korraga kõiki inimese vajadusi. Kui on vaja, siis aitab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja inimesel suhelda perearsti

või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga. Töötukassa juhtumikorraldaja suunab abivajaja täiendkoolitusele, leiab inimesele töötamiseks tugiisiku või aitab muude tööga seotud küsimuste korral. Koos inimesega otsitakse sobivaimaid lahendusi. Eri rehabilitatsiooniprogrammide kasutusele võtmine võimaldab pakkuda tõendus põhiseid sekkumisi ning suunata inimene kiiremini sobivale teenusele.

Valdkondade ülesed arendused ja koostöö aitab riigi abivajajale lähemale tuua ja olemasolevaid ressursse otstarbekamalt kasutada. Ehkki muudatused võivad esialgu segadust juurde tuua, on eesmärgiks ühtsemad inimesekesksed lahendused, kus teenused koonduvad ümber inimeste vajaduste ning inimest aidatakse just siis, kui ta abi vajab. Tahame, et inimesed saaksid elada võimalikult täisväärtuslikku elu. Mitmed juurdunud mõttemallid vajavad veel murdmist, ent sellest, kui igäüks saab olla õnnelik ja iseseisev, võidame kõik.

